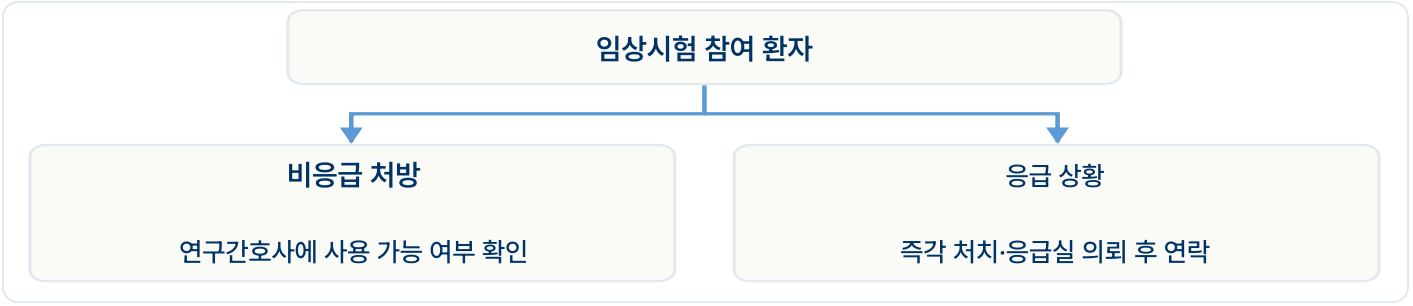
항암 환자 수액·영양 처치

임상시험 참여 여부와 정맥로를 먼저 확인

경구·경장 영양이 우선이고 수액은 보조다. 표준 영양수액 대부분은 투여할 수 있지만 임상시험 참여자는 비응급 처방 전에 연구간호사와 확인한다.

핵심 판단의 흐름



상황에 맞는 수액·영양 선택

상황	강의에서 제시한 선택
탈수·섭취 저하	생리식염수·하트만액으로 수분과 전해질을 보충한다.
에너지·단백 보충	포도당 5–10%는 혈당을 보며 사용. 아미노산 제제도 가능하며 경구·경장 영양을 우선한다.
섭취가 매우 불량	지질 포함 영양제를 고려. 고농도·장기 정맥영양은 중심정맥이 필요해 상급병원과 연계한다.

투여 전 안전 확인

확인할 항목	처치에 반영
체액·장기 상태	체중·부종·심폐 상태, 전해질·혈당·신기능을 보며 속도와 용량을 조절한다.
장기간 금식	재급식증후군에 유의해 천천히 시작하고 인·칼륨·마그네슘을 확인한다.
케모포트	전용 Huber needle·무균술 필요. 익숙하지 않으면 말초 정맥로가 안전하다. 발적·통증·발열은 포트 감염을 의심해 의뢰한다.

진료실에서 기억할 점

비응급: 연구간호사에게 약제·수액 사용 가능 여부를 먼저 확인. 응급: 환자 안전을 우선해 처치·의뢰하고 즉시 연락한다.